GUIDA DI AUTOVALUTAZIONE · EQUILIBRIO

Quando la testa spegne il corpo

Erezione, ansia da prestazione e quello che nessuno ti spiega.
Per uomini che vogliono capirci qualcosa prima di decidere.

Ivan Ferrero

Psicologo psicoterapeuta · Albo degli Psicologi della Lombardia, sezione A, n. 16571 dal 2006
equilibrio.ivanferrero.it · ivan@ivanferrero.it · Edizione 2026

Nota al lettore

Prima di iniziare ti devo dire tre cose brevi.

La prima riguarda il "tu" che incontrerai da qui in avanti. È un "tu" personale, non clinico. L'ho tarato su chi sta vivendo la cosa in prima persona, cioè, quasi sempre, su un uomo. Ecco perché in qualche punto questo "tu" suonerà molto vicino alla pelle, e quella vicinanza non è un caso.

La seconda riguarda Andrea, l'uomo che incontrerai tra poche righe. Andrea è un caso composito. Nessuna persona reale è riconoscibile nella sua storia. Ho messo insieme elementi che ho incontrato, negli anni, in molti percorsi: l'età, il lavoro, la sera che non andò come avrebbe dovuto, la paura che si installò dopo. Nessuno di questi pezzi viene da una singola persona, ma messi insieme raccontano un meccanismo che si ripete, e forse parlano anche di te.

La terza riguarda cosa è e cosa non è questo testo. Questa guida non è una diagnosi e non sostituisce una valutazione clinica. E c'è una cosa che ti chiedo di aver fatto, o di fare: parlarne almeno una volta con un medico. Le difficoltà di erezione possono avere anche cause fisiche, e quelle si escludono con esami, non con una guida. Io ti parlo di quello che succede **quando il corpo, sul piano organico, funziona** e il problema, nonostante questo, resta. Quella è la zona di cui mi occupo io. Per il resto, questa guida ti consegna una mappa. La mappa serve a orientarsi, non a coincidere con il territorio, e se al termine della lettura di questa guida desidererai percorrere questo territorio, ti basterà scrivermi a ivan@ivanferrero.it .

Indice narrativo

Sei tappe, una frase ciascuna, perché tu sappia dove stiamo andando.

I. Lo specchio. La sera in cui, per la prima volta, la paura è arrivata prima del desiderio.

II. Il ciclo. Il meccanismo a quattro tempi che, una volta partito, si alimenta da solo — e perché non è colpa della tua volontà.

III. Quello che hai già provato. La pillola, gli integratori, il "rilassati", l'evitare. Perché non bastano, e cosa stavano davvero cercando di sistemare.

IV. Il corpo non mente. Come funziona davvero l'erezione, perché l'ansia la spegne sul nascere, cosa alimenta il meccanismo nel tuo caso, e le frasi che quasi tutti gli uomini hanno in testa senza averle mai scelte.

V. Cinque domande. Un modo onesto per metterti davanti a un primo quadro, senza dirti chi sei.

VI. E adesso. Cosa si fa, quando si decide di farci qualcosa. E cosa succederà nella tua casella di posta nelle prossime settimane.

PARTE I

Lo specchio: ti ci riconosci?

Andrea, la seconda volta

Ti ci riconosci?

Andrea ha trentasei anni. Non è la prima volta. È la seconda.

La prima volta era stata un mese prima. Una sera come tante, lei accanto, e a un certo punto il corpo semplicemente non aveva risposto. Era successo e basta. Aveva bevuto un po' di più, aveva dormito poco quella settimana, aveva la testa ancora mezza dentro una mail di lavoro. Sul momento non ci aveva nemmeno dato troppo peso. "Capita", aveva detto lei, e aveva ragione. Capita a tutti, prima o poi, ed è esattamente quello che era: un episodio.

Il problema non è stata la prima volta. Il problema è quello che è successo dentro la testa di Andrea **nelle settimane in mezzo**.

Perché adesso è la seconda volta. Stessa stanza, stessa donna, e Andrea si accorge di una cosa che un mese fa non c'era. Mentre la abbraccia, una parte di lui non è lì con lei. È un passo indietro, che osserva, che controlla, che si chiede, mentre sta succedendo: *e se non funziona di nuovo?*

Ecco. In quel preciso istante, prima ancora che il corpo abbia avuto modo di decidere qualcosa, la domanda ha già spostato tutto.

Perché un uomo che si chiede se avrà un'erezione ha già smesso, in quel momento, di essere un uomo che desidera. È diventato un uomo che si controlla. E il desiderio e il controllo non possono stare nella stessa stanza. Quando entra uno, l'altro esce.

Andrea non lo sa ancora, ma non sta combattendo contro il suo corpo. Sta combattendo contro la sua stessa attenzione, e la sta perdendo, non perché è debole, ma perché in quella battaglia si perde sempre: più ti sforzi di controllare un'erezione, più la allontani, esattamente come più ti sforzi di addormentarti alle tre di notte, più resti sveglio.

Questa è la prima cosa che voglio tu sappia, prima di tutte le altre: **se ti riconosci in Andrea, il tuo problema non è un problema di erezione. È un problema di paura dell'erezione.** Sono due cose diverse, hanno cause diverse, e si risolvono in modo diverso. La maggior parte degli uomini passa anni a lavorare sulla prima quando il problema è la seconda. Ed è per questo che non si sblocca niente, ed è per questo che stai leggendo questa guida.

Non sei un caso raro (e non sei rotto)

Lascia che ti tolga subito un peso di dosso.

La difficoltà di erezione su base psicologica, quella che gli esami non trovano perché non c'è niente di rotto da trovare, è una delle cose più comuni che un uomo possa sperimentare. Non è una malattia rara. E del resto non è neanche una malattia. Non è un difetto di fabbrica. Non è il segnale che "qualcosa non va in te" in senso profondo. È un meccanismo, e i meccanismi capitano a chiunque abbia la combinazione giusta di circostanze nel momento giusto.

E qui c'è la parte che quasi nessuno ti dice: capita più spesso proprio agli uomini a cui "importa di più". Quelli che funzionano, che si impegnano, che sono abituati a controllare le cose e a portarle a casa. Perché il controllo, che nel lavoro e nella vita è una virtù, nel letto è esattamente il problema. L'erezione è una delle pochissime cose importanti che un uomo **non può ottenere sforzandosi**. Può solo permetterle di accadere. E un uomo allenato a ottenere le cose sforzandosi, davanti all'unica cosa che funziona al contrario, si trova senza strumenti.

Quindi no: non sei rotto. E no, non sei solo. Sei dentro un meccanismo che conosco bene, e che ha una via d'uscita, ma questa via d'uscita non passa da dove la stai cercando.

> *Su una cosa torneremo in una delle email delle prossime settimane: la differenza tra "è stato un brutto momento" e "si è installato qualcosa". Tienila a mente, perché è la distinzione che cambia tutto.*

PARTE II

Il ciclo: come una volta diventa sempre

I quattro tempi

Quasi nessuna difficoltà di erezione psicogena nasce dal nulla. Nasce da un episodio. Uno qualunque, innocente, che poi un meccanismo trasforma in abitudine. Te lo disegno nei suoi quattro tempi, perché tu possa riconoscerlo nella tua vita e non solo a parole.

Primo tempo: l'episodio. Una sera il corpo non risponde. Le ragioni sono banali e fisiologiche: stanchezza, alcol, stress, un pensiero di traverso, semplicemente una serata storta. A tutti gli uomini succede, e nella stragrande maggioranza dei casi non significa niente. Fin qui non c'è nessun problema clinico. C'è solo una sera andata male.

Secondo tempo: l'interpretazione. Qui si decide tutto. L'uomo prende quell'episodio e ci attacca sopra un significato: "e se fosse l'inizio?", "e se ora sono diventato uno così?", "e se la prossima volta...". L'episodio smette di essere un fatto e diventa una minaccia. È in questo passaggio: non nel letto, ma nella testa, nei giorni dopo, che una sera storta comincia a trasformarsi in un problema.

Terzo tempo: la vigilanza. La volta dopo, l'uomo entra nell'intimità con un compito nuovo, che prima non aveva: *controllare se funziona*. Si guarda. Si monitora. Diventa lo spettatore di sé stesso invece che il protagonista. In clinica questo si chiama "fare lo spettatore" (spectatoring, nel nostro gergo tecnico), ma il nome conta poco. Conta che è difficile essere allo stesso tempo dentro un'esperienza e fuori a sorvegliarla, e che lo spettatore si accende sempre nello stesso momento: quando senti che deve funzionare. È lo stesso meccanismo del calciatore che sbaglia il rigore proprio la volta in cui pensa a come lo sta calciando, o di chi non riesce a dormire perché ci sta provando con tutte le forze. L'erezione ha bisogno che tu sia dentro, e dentro si torna anche dopo essere usciti: nessuno resta immerso dall'inizio alla fine, e il punto non è non uscire mai, è accorgersene e rientrare.

Quarto tempo: la conferma. La vigilanza genera tensione, la tensione spegne l'erezione (tra poco ti spiego perché, ed è pura biologia), e il mancato risultato viene letto come la prova che la paura era fondata. "Visto? Lo sapevo." Il cerchio si chiude. E un cerchio chiuso, la volta successiva, parte già dal secondo tempo. Poi dal terzo. Finché la paura non arriva prima ancora che tu entri in quella stanza.

Perché non è un problema di volontà

Guarda bene il ciclo, perché contiene una buona notizia nascosta.

In nessuno dei quattro tempi c'è la volontà. Non c'è un punto in cui Andrea "si lascia andare" o "non si impegna abbastanza". Al contrario: il problema è che si impegna troppo. Il ciclo è alimentato dallo sforzo, non dalla pigrizia. Ogni volta che Andrea ci mette più volontà, "stasera mi concentro, stasera ci riesco", gira la chiave nel verso sbagliato, perché aggiunge controllo a una cosa che muore di controllo.

Questo è il motivo per cui tutti i consigli che hai ricevuto, da te stesso o dagli altri, hanno fallito. "Rilassati" è un comando impossibile da eseguire a comando. "Non pensarci" ti fa pensare. "Impegnati di più" alza la posta e quindi la paura. Sono tutti tentativi di vincere con la volontà una partita che con la volontà non si vince. La direzione che funziona è un'altra, e non chiede di togliere qualcosa dalla testa ma di portare l'attenzione verso qualcosa: le sensazioni che ti piacciono, quello che desideri in quel momento, vissuti da dentro e non osservati da fuori. L'attenzione uscirà ancora, ed è previsto; quello che si allena è il ritorno.

E se non è un problema di volontà, allora non è nemmeno un problema di carattere. Non dice niente su quanto vali, su quanto sei uomo, su che partner sei. Dice solo che un meccanismo si è avviato, e che i meccanismi si disinnescano con il metodo giusto, non con lo sforzo.

> *Anche di questo ti riscriverò: del perché "impegnarsi di più" sia il consiglio più sbagliato che esista, in questo campo.*

PARTE III

Quello che hai già provato

La pillola, gli integratori, e gli altri rimedi

Se sei arrivato fin qui, è probabile che tu abbia già provato qualcosa. Quasi tutti ci passano. Vale la pena guardare insieme cosa hai provato e perché, nella maggior parte dei casi psicogeni, non è bastato.

La pillola blu. È un farmaco serio e in molte situazioni utile, e va detto: quando la causa è fisica, può fare la differenza. Ma guarda cosa fa, esattamente. Lavora sull'idraulica: aiuta il sangue ad affluire e a restare. Il punto è che nella DE psicogena l'idraulica non è guasta. Il rubinetto lo chiude la testa, a monte. Così succede spesso una di queste due cose: o non funziona come speravi (perché l'ansia è più forte del farmaco), oppure funziona, ma ti lascia con la convinzione di

non potercela fare "da solo", e quella convinzione diventa benzina nuova per la paura. In entrambi i casi il meccanismo resta lì, intatto, sotto.

Gli integratori. Maca, ginseng, panax, le formule che promettono "vigore". Nella stragrande maggioranza, quando c'è un effetto, è effetto aspettativa: ci credi, ti rilassi un po', e quel po' di rilassamento aiuta il che, tra l'altro, conferma che il problema era la testa, non la chimica. Ma è un sollievo che dura finché dura la fiducia nel barattolo, e non insegna niente al sistema.

"Rilassati", "bevi un bicchiere", "non pensarci". I consigli da bar, e talvolta il bicchiere di troppo che, paradossalmente, abbassando l'ansia ha funzionato una volta, e così è diventato una stampella. Il problema è che disattivano la vigilanza con un anestetico esterno invece che insegnarti a non attivarla.

L'evitamento. Il più silenzioso, e il più costoso. Si comincia a evitare. Si va a letto "stanchi", si rimanda, si crea distanza, si trasforma l'intimità in un terreno minato da aggirare. Toglie l'ansia nell'immediato, ma allarga il problema: conferma al cervello che lì c'è un pericolo, raffredda la relazione, e aggiunge alla difficoltà di erezione un secondo strato fatto di distanza e di non detto.

Cosa stavano cercando di sistemare

Nessuna di queste cose è stupida. Ognuna stava cercando di sistemare qualcosa di reale. Ma guardale tutte insieme e vedi cosa hanno in comune: **lavorano tutte sul sintomo, nessuna sul meccanismo che sta alla base.** Provano a forzare l'erezione (la pillola), a comprarla (gli integratori), a rubarla abbassando la guardia (l'alcol), o a non doverla affrontare (l'evitamento).

Ma se il problema è il ciclo della paura che hai visto nella Parte II, allora finché il ciclo gira, qualunque cosa agisca solo sul singolo episodio è destinata a essere una toppa. Il giorno dopo il ciclo è ancora lì. E spesso è più forte, perché a ogni tentativo fallito si aggiunge una prova in più alla tesi "non ce la faccio".

Il punto da cui si esce non è "come ottengo un'erezione stasera". È "come smonto il meccanismo che me la sta spegnendo". Sono due domande diverse. Tu, probabilmente, hai lavorato per mesi sulla prima. Questa guida ti sta proponendo, per la prima volta, di guardare la seconda.

PARTE IV

Il corpo non mente (e non ti sta tradendo)

Due interruttori che non possono stare accesi insieme

Adesso ti spiego la cosa che, da sola, a molti uomini toglie metà del peso. È semplice, è biologia, e quasi nessuno gliel'ha mai detta.

Il tuo corpo ha due modalità di funzionamento, gestite da due rami dello stesso sistema nervoso.

C'è la modalità **allarme**. Quando il cervello percepisce una minaccia (un pericolo, una scadenza, o anche solo la paura di fallire) accende il ramo simpatico. Il corpo si prepara ad affrontare o a fuggire: il cuore accelera, i muscoli si tendono, il sangue va alle gambe e alle braccia, via dalla periferia. È un sistema vecchio di milioni di anni e ha un solo scopo: tenerti vivo davanti a una minaccia. E davanti a una minaccia il sesso è l'ultima delle priorità del corpo, e infatti viene puntualmente spento.

E c'è la modalità **quiete**. Quando il cervello percepisce sicurezza, accende il ramo parasimpatico. Il corpo si lascia andare: il respiro si allarga, i muscoli mollano, il sangue può affluire dove serve. **L'erezione vive qui.** È un fenomeno della quiete, non dell'allarme. Ha bisogno di un corpo che si fida d ise stesso, non di un corpo che combatte contro se stesso.

Ed ecco il punto: questi due interruttori non possono essere accesi insieme. È fisicamente impossibile essere allo stesso tempo in allarme e in quiete. Quando l'ansia accende l'allarme, l'erezione si spegne, non per scelta, non per debolezza, ma perché il corpo sta letteralmente facendo l'opposto di quello che servirebbe.

Quindi quando, nel momento dell'intimità, ti chiedi con ansia "funzionerà?", quella domanda non è un pensiero neutro. È un interruttore. Accende l'allarme. E l'allarme spegne, in tempo reale, esattamente la cosa di cui hai paura. Il tuo corpo non ti sta tradendo, ti sta obbedendo alla lettera: gli stai dicendo "c'è un pericolo", e lui sta facendo quello che si fa in un pericolo.

Lascia che lo dica chiaro, perché è la chiave di tutto: **la tua erezione funziona benissimo. Sta solo aspettando che tu smetta di trattarla come un esame.**

Un acceleratore, un freno, e un'erezione che va e viene

Il quadro della pagina precedente è vero, ed è quello grande. Ma dentro c'è un dettaglio più fine, che vale la pena conoscere perché spiega una cosa che a molti uomini sembra assurda: come si possa desiderare tantissimo una persona e non avere l'erezione con lei.

Il sistema che governa la tua risposta sessuale non è un interruttore solo con due posizioni. Assomiglia di più a due pedali. Uno spinge: è tutto ciò che ti eccita, che ti attira, che ti fa venire voglia. L'altro frena: è tutto ciò che ti blocca, ti mette in allerta, ti fa alzare la guardia. Non sono la stessa cosa vista da due lati. Sono due sistemi indipendenti, che lavorano nello stesso momento, e ognuno di noi li ha tarati in modo diverso: c'è chi ha l'acceleratore facile, e c'è chi ha il freno molto sensibile, e questo non dice niente su quanto sei virile o quanto la desideri.

Ecco perché la domanda "ma allora non mi piace più?" quasi sempre è la domanda sbagliata. Non è che l'acceleratore sia sparito. È che il freno è premuto più forte. E il freno, in quasi tutte le storie come quella di Andrea, non è premuto dal poco desiderio: è premuto dal rischio di fallire. Quella seconda sera Andrea desiderava esattamente come un mese prima. Aveva solo, per la prima volta, un piede sul freno.

Questa distinzione conta perché sposta il bersaglio. Non c'è niente da aggiungere all'acceleratore: nessun integratore, nessuna fantasia nuova, nessuno sforzo di volerlo di più. C'è da togliere il piede dal freno. È un lavoro diverso, e si fa in un altro punto.

E c'è una seconda cosa, che quasi nessuno ti ha detto: l'erezione non è una cosa che c'è o non c'è.

È una cosa che sale, scende e risale, anche dentro la stessa mezz'ora, anche quando va tutto bene. Le erezioni parziali sono normali. Il calo a metà è normale. Di notte ne hai diverse, e tra una e l'altra scende del tutto, ogni notte, da sempre, senza che tu te ne accorga.

Il punto è cosa succede quando quel calo capita mentre sei sveglio e con qualcuno. La maggior parte degli uomini, in quel momento, fa due cose insieme: si spaventa e accelera. E sono esattamente le due che chiudono il rubinetto, perché la paura accende l'allarme e l'accelerazione aggiunge sforzo dove servirebbe quiete. Il calo, da solo, sarebbe stato una pausa. Diventa un finale solo perché viene letto come un finale.

Quando si lavora su questo, quel momento non si evita: si guarda. Si lascia che l'erezione scenda, senza rincorrerla, per vedere cosa succede dopo. E quello che succede dopo, se nel frattempo non è scattato l'allarme, molto spesso è che risale. Non è un trucco: è il modo in cui il corpo ha sempre funzionato, anche prima che tu cominciassi a guardarlo.

Cosa alimenta il meccanismo, nel tuo caso

Il ciclo della paura ha bisogno di un innesco e di un terreno. L'innesco è quasi sempre un episodio banale. Il terreno, invece, cambia da uomo a uomo. Ti elenco i fattori che vedo più spesso fare da terreno, così puoi sentire quali risuonano maggiormente con la tua situazione. Non sono diagnosi: sono direzioni in cui guardare.

Lo stress e l'iper-controllo. Se sei un uomo molto performante, abituato a tenere tutto sotto controllo, porti nel letto lo stesso assetto da prestazione che usi di giorno. Ma il letto è l'unico posto dove "dare il massimo" sabota il risultato. Spesso è il terreno principale.

La stanchezza e le abitudini. Sonno cronicamente corto, troppi impegni, alcol di troppo, periodi di vita spremuti. Il corpo affaticato ha una soglia più bassa, e una cilecca da stanchezza diventa facilmente l'episodio-innesco del ciclo.

Un episodio che ha fatto da detonatore. A volte c'è una serata precisa, magari mesi fa, magari con una persona che contava molto, in cui è andata male. E da lì la paura ha messo radici, anche se la vita intorno è tranquilla.

La relazione. A volte è una tensione non detta con la partner. A volte è l'opposto: una persona che conta così tanto che la posta in gioco diventa schiacciante. La difficoltà di erezione qui parla anche di quello che succede tra due persone, non solo dentro uno.

L'umore. Un periodo di tristezza, di calo, di poco desiderio per tutto, non solo per il sesso. Quando l'umore è sotto, anche il desiderio scende, e l'erezione segue il desiderio.

E un fattore di cui si parla poco. Per alcuni uomini, soprattutto ma non solo i più giovani, il terreno è anche un altro: l'abitudine del cervello a un'eccitazione molto rapida e molto intensa, come quella che offre la pornografia. Non è una questione morale, e non c'entra niente con la "quantità". È una questione di taratura: un cervello che si è abituato a partire da zero a cento in pochi secondi, con stimoli sempre nuovi ed estremi, può trovare l'eccitazione reale più lenta, più sfumata, fatta di una persona sola, sottotono rispetto a quello a cui si è tarato. E siccome l'erezione segue l'eccitazione reale, non il dovere, può faticare a partire. Se di tutti questi fattori è questo quello che ti ha fatto drizzare le antenne più degli altri, tienilo da parte: è un filo che vale la pena tirare con calma, e si può tirare insieme.

Nessuno di questi fattori è una condanna. Sono terreni, e i terreni si possono cambiare, ma il primo passo è sapere su quale stai camminando.

Le frasi che quasi tutti hanno in testa

C'è un ultimo terreno, ed è il più invisibile di tutti, perché non sembra un terreno: sembra la realtà.

Sono frasi. Nessuno te le ha insegnate a voce, e tu non le hai mai scelte. Circolano da sempre, nei discorsi tra ragazzi, nei film, nelle battute, nel silenzio di quello che non si dice mai, e a un certo punto sono entrate. Le riconosci perché quando ti passano per la testa non suonano come opinioni: suonano come fatti.

Leggile una per una, con calma, e segna quelle in cui senti qualcosa di tuo, anche solo a metà.

"*Un uomo vero è sempre pronto.*"

"*Se non ho l'erezione completa, non posso fare niente.*"

"*La penetrazione è l'unico sesso che conta davvero.*"

"*Se non funziona una volta, non funzionerà più.*"

"*Lei penserà che non la desidero, o che c'è qualcun'altra.*"

Guarda cosa fanno queste frasi, tutte insieme, quando entri in una stanza con qualcuno. Alzano la posta. Trasformano una serata in una verifica, un corpo in un risultato, un calo in una condanna. Sono, letteralmente, un piede sul freno: ognuna di loro descrive un modo di fallire, e un cervello che ha in mente un modo di fallire sta già facendo il secondo tempo del ciclo che hai letto nella Parte II.

E nessuna delle cinque regge, se la guardi da vicino. Un uomo vero, come chiunque, ha giornate e notti diverse tra loro. Un'erezione parziale non è un'erezione mancata. Il sesso è molto più largo di un solo gesto, e restringerlo a quello è proprio ciò che lo rende un esame. Una volta non è una regola. E quello che la persona accanto a te pensa, in genere, non lo sai: lo immagini, e quasi sempre lo immagini peggio di com'è.

Quelle che hai segnato non sono difetti tuoi. Sono le frasi da cui vale la pena partire, il giorno in cui deciderai di partire.

E i tempi? Quello che dicono i minuti, e quello che conta di più

Fin qui abbiamo parlato dell'erezione, ma molti uomini che arrivano a questa pagina portano con sé anche un'altra domanda, che spesso fanno ancora più fatica a dire ad alta voce, cioè se il problema non sia anche, o soprattutto, il fatto di finire troppo presto; una domanda che a volte arriva insieme alla paura di perdere l'erezione e a volte da sola, e che merita una pagina tutta sua, perché anche qui

quello che si crede di sapere e quello che risulta dai dati sono due cose piuttosto lontane.

Partiamo dai numeri, che su questo tema esistono e sono stati raccolti con attenzione: in uno studio fatto in cinque paesi, cinquecento coppie hanno misurato per quattro settimane il tempo che passava dall'inizio della penetrazione all'eiaculazione, e il valore centrale, quello che lascia metà degli uomini sopra e metà sotto, è stato di poco più di cinque minuti, con differenze enormi da una coppia all'altra, da meno di un minuto a più di quaranta, e con tempi che tendono ad accorciarsi un po' con l'età. La misura con cui tanti uomini si giudicano, insomma, viene più spesso dai film e dai racconti degli amici che dalla vita di tutti i giorni, dove i tempi sono più brevi e molto più vari di quanto si immagini.

C'è poi un secondo dato, che forse rassicura ancora di più: i tempi cambiano da una volta all'altra anche negli uomini che non hanno nessuna difficoltà, così che una sera più veloce del solito, dopo giorni di lontananza, con una persona nuova o in un periodo di tensione, fa parte del modo normale in cui funziona il corpo e non è il segnale che qualcosa si è rotto. In un'ampia indagine su più di duemilacinquecento coppie, circa un uomo su cinque diceva di eiaculare troppo presto, e due su tre di loro rientravano in due quadri che non sono un disturbo: chi è veloce solo ogni tanto, in modo irregolare, e chi si sente veloce pur avendo tempi del tutto nella media. Per entrambi la cosa più utile, all'inizio, è proprio sapere come stanno davvero le cose.

Il numero che conta di più, però, non sono i minuti: chi ha studiato a fondo questi uomini ha visto che il disagio e la soddisfazione dipendono molto meno dalla durata che dalla sensazione di avere in mano il momento, di accorgersi di dove si è e di poter scegliere; e quando si chiede alle partner che cosa pesi di più, la risposta più frequente è un uomo lontano, tutto preso dal risultato, più ancora di un rapporto breve. È una buona notizia, perché il controllo, a differenza dei minuti, è qualcosa su cui si può lavorare, ed è anche il motivo per cui il cronometro non aiuta: misurarsi mentre succede vuol dire tornare a guardarsi da fuori, che è esattamente lo spettatore che hai incontrato nelle pagine precedenti.

Se insieme ai tempi c'è anche la paura di perdere l'erezione, vale la pena farsi una domanda precisa, cioè se ti capiti di affrettarti per finire prima che l'erezione cali: molti uomini lo fanno senza accorgersene, e in quel caso la fretta non è un secondo problema accanto al primo, ma un modo di proteggersi dal primo, lo stesso ciclo della paura che hai letto nella Parte II guardato da un altro lato.

Ci sono poi situazioni in cui i tempi brevi sono un tema a sé, e succede soprattutto quando ci sono da sempre, dai primi rapporti, quasi ogni volta e con la sensazione di non poterci fare niente: in quel caso il primo interlocutore è il medico, che ha a

disposizione anche dei farmaci, e il lavoro psicologico lo affianca, sul controllo che senti e sul modo in cui vivi quei momenti. Quando invece i tempi si sono accorciati dopo un periodo in cui andava diversamente, la prima cosa è capire che cosa è cambiato, ed è lì che l'ansia, la pressione e la relazione pesano di più; in tutti e due i casi parlarne con un medico, come per l'erezione, è un gesto di completezza e non un allarme.

Il gesto, se vuoi cominciare da qui, è semplice: le prossime volte, invece di chiederti quanto è durato, chiediti dopo quanto ti sei sentito dentro il momento e quanto ti è sembrato di poterlo scegliere, perché è quella la misura che dice di più.

PARTE V

Cinque domande

Un primo quadro, onesto

Arrivato qui è probabile che tu abbia voglia di un dato un po' più preciso che una semplice sensazione. Esiste uno strumento breve e serio, usato anche in ambito clinico, fatto di cinque domande sul funzionamento delle ultime settimane. Non ti dice chi sei e non è una diagnosi. Ti dà un punto di partenza, un primo quadro su cui ragionare.

Le cinque domande riguardano, in sostanza: quanta fiducia hai in questo momento nella tua capacità di avere e mantenere un'erezione; quanto spesso l'erezione, quando c'è, è abbastanza salda per iniziare e per arrivare fino in fondo a un rapporto; e quanta soddisfazione provi. Sono semplici, ma messe insieme fotografano qualcosa di reale.

Lo trovi pronto, con il calcolo automatico, qui:

https://equilibrio.ivanferrero.it/autovalutazione-de/

il test ti dà il punteggio, questa guida ti spiega come leggerlo

Due minuti, cinque domande, risultato immediato e anonimo.

Come leggere il tuo risultato (senza farne una sentenza)

Quando avrai il tuo numero, ecco come guardarlo. Lo strumento colloca il risultato in fasce, dalle difficoltà minime a quelle più marcate. Ma il numero, da solo, è meno importante di due cose che voglio tu tenga a mente.

La prima: **la fascia dice "quanto", non dice "perché".** Due uomini con lo stesso punteggio possono avere storie opposte — uno con una causa fisica, uno dentro il ciclo della paura che hai letto qui. Il numero misura l'impatto, non l'origine. L'origine si capisce parlandone, e ricordando il punto della Nota al lettore: le cause fisiche si escludono con un medico.

La seconda, e più importante: **se ti riconosci nel meccanismo descritto in questa guida, ossia la paura che arriva prima, lo spettatore di sé, il corpo che si chiude sotto sforzo, allora il dato che conta non è il punteggio di oggi: è quanto in fretta quel punteggio cambia quando il meccanismo si disinnesca.** E nei quadri psicogeni, quando si lavora sul meccanismo giusto, cambia. Non ti prometto tempoi brevi e un Percorso facile e lineare, perché non sarei onesto e non sarebbe corretto nei tuoi confronti: ogni storia è diversa. Ma è la direzione in cui questo tipo di problema, lavorato bene, tende a muoversi.

PARTE VI

E adesso

Cosa si fa, quando si decide di farci qualcosa

Se ti sei riconosciuto in queste situazioni, la domanda che hai in testa adesso è probabilmente: e quindi, in concreto, cosa facciamo?

Non ti vendo una formula, perché chi te la vende ti sta mentendo. Ti dico come si lavora su questo, in modo che tu sappia di cosa si tratta prima ancora di parlarmi.

Si parte dal capire il **tuo** ciclo: qual è stato l'innesco, su quale terreno è cresciuto, in quale dei quattro tempi entri ormai per automatico. Questa parte è già metà del lavoro, perché un meccanismo visto in chiaro perde gran parte del suo potere.

Poi si lavora per spostare l'attenzione dal controllo all'esperienza: non con la forza di volontà, perché hai visto anche te che lì si perde sempre, ma con un metodo che insegna al corpo a tornare nella modalità "quiete" e a starci. Si tolgono, passo dopo passo, le condizioni che tengono acceso l'allarme. E quando serve, si guardano anche le cose intorno: la relazione, l'umore, le abitudini, e, se è quello il tuo filo, anche il modo in cui il cervello si è tarato sull'eccitazione (ricordi il nostro discorso sul consumo di materiale pornografico?).

E c'è una distinzione che, da sola, cambia il senso di tutto quello che nel frattempo provi a fare per conto tuo. Toccarsi per sentire cosa si sente è una cosa. Toccarsi per controllare se funziona ancora è un'altra. Il gesto è identico, la domanda no, e il

risultato nemmeno: nel primo caso stai stando dentro un'esperienza, nel secondo hai riaperto l'esame, e l'esame è esattamente il meccanismo che stai cercando di smontare. Vale la pena saperlo fin d'ora, perché la verifica è la tentazione più naturale del mondo quando si ha paura, ed è anche il modo più veloce per rimettere in moto il ciclo. Quando si comincia a lavorarci davvero, la prima cosa che si toglie sono i test.

Non è un percorso infinito e non è un divano dove si parla per anni. È un lavoro mirato, con un inizio, una direzione e dei passi concreti. La cornice clinica con cui lavoro è strutturata in fasi, pensata proprio per problemi come questo, dove il corpo e la testa vanno sciolti insieme.

Il passaggio di testimone

Voglio chiudere con una promessa piccola e precisa.

Hai scaricato una guida, non hai preso un impegno. È giusto così. Ma so anche cosa succede, di solito, dopo una lettura come questa: nei giorni che vengono affiorano pensieri specifici. "Forse esagero." "Ho già provato, non cambierà." "Non posso parlarne con nessuno." "Ma la psicoterapia servirà davvero, per una cosa così?"

Li conosco questi pensieri, uno per uno, perché li ho visti arrivare centinaia di volte, sempre più o meno nello stesso ordine. Per questo, nelle prossime settimane, ti scriverò ancora. Non per venderti qualcosa e non per metterti fretta. Ti scriverò perché a ognuno di quei pensieri c'è qualcosa da rispondere, e perché dopo una lettura come questa, di solito, è proprio nel rispondere a quei pensieri che le cose si muovono.

Quando vorrai, mi trovi. E se a un certo punto sentirai che è il momento di parlarne con una voce e non con una pagina, basterà una tua riga inviata al mio indirizzo email ivan@ivanferrero.it .

Per ora, ti basti questo: il tuo corpo non è rotto, la tua paura ha una logica, e quella logica si può smontare.

Ivan Ferrero

Psicologo psicoterapeuta. Albo Lombardia n. 16571

Appendici

A. Cosa non è questa guida. Non è una diagnosi, non sostituisce una valutazione clinica, non è un protocollo di auto-cura. È una mappa per orientarti e per

decidere, con più consapevolezza, se e quando chiedere aiuto. Le difficoltà di erezione possono avere cause organiche: il primo passo, sempre, è escluderle con un medico.

B. Su Andrea. Andrea è un caso composito, costruito unendo elementi ricorrenti incontrati in molti percorsi clinici. Nessuna persona reale è riconoscibile nella sua storia.

C. Una riga sulle fonti. Il meccanismo descritto (l'auto-osservazione ansiosa che interferisce con la risposta sessuale, l'antagonismo tra attivazione d'allarme e risposta erettiva) poggia su conoscenze consolidate della psicologia clinica della sessualità. Per ogni decisione che riguarda la tua salute, la fonte giusta resta un professionista che ti ascolta di persona.